Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Lajeado

Rua Paulo Frederico Schumacher, 77 - Bairro: Moinhos - CEP: 95900780 - Fone: (51) 3710-1500 - Email: frlajeado2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007743-26.2024.8.21.0017/RS

AUTOR: ALICIA MOTA DE ALMEIDA

RÉU: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

SENTENÇA

ALICIA MOTA DE ALMEIDA ajuizou a presente **AÇÃO DE** em face de **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.**, todos qualificados, alegando que é portadora de Neurofibromatose tipo 2 (NF2) e em grau severo, doença genética autossômica dominante rara, associada a numerosos tumores do sistema nervoso central como schwannomas, meningiomas e ependimomas, de natureza hereditária. Disse que Schwannoma, também conhecidos por neurinoma, de forma simples e bastante informal, é um tumor benigno intra cranial que se origina nas células que recobrem o nervo vestibular, responsável pelo equilíbrio e audição. A presença desses tumores causa zumbidos, tonturas, desiquilíbrio e redução da acuidade auditiva e que os sintomas mais comuns são Cefaleia, náuseas, convulsões, surdez completa e paralisia facial, os quais estão associados ao crescimento dos tumores intracranianos, podendo levar ao óbito. Informou que entre os 15 e 16 anos, realizou cirurgia, a qual trouxe inúmeras sequelas como surdez total bilateral e paralisia facial, bem como em Novembro/2023 foi submetida a uma delicada cirurgia para retirada de tumor na coluna cervical e que após recuperada desta cirurgia, o médico especialista apontou como tratamento indicado o AVASTIN (Bevacizumabe), a fim de evitar o crescimento dos tumores existentes e/ou diminuí-los, bem como evitar o surgimento de novos tumores. Relatou que foi solicitado à Unimed, autorização para realizar o tratamento, tendo sido negado, eis que o medicamento não está previsto no Rol da ANS, bem como não houve qualquer comprovação da existência de eficácia e trata-se de medicamento *off label.* Sustentou que o contrato que a autora é beneficiária prevê a cobertura garantida, conforme prescrição do médico assistente, de modo que o plano não pode se recusar a custear o tratamento. Pleiteou a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado que a ré forneça de imediato o tratamento do medicamento AVASTIN (Bevacizumabe), a ser executado no CRON, em Lajeado/RS. Requereu a procedência da ação, bem como o pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 8.000,00. Por fim, requereu a inversão do ônus da prova e a concessão do benefício da AJG. Atribuiu à causa o valor de R$ 8.000,00. Juntou documentos.

Intimada a parte autora para adequar o valor da causa, devendo ser a soma dos danos morais pretendidos, com o valor do tratamento prescrito ou 12 vezes o valor do medicamento (evento 3, DESPADEC1).

A parte autora emendou a inicial, adequando o valor da causa para R$ 215.512,64 (evento 6, EMENDAINIC1).

Intimada a parte autora para demonstrar fazer jus ao benefício da AJG, juntando documentos hábeis (evento 7, ATOORD1), tendo sido posteriormente cumprido (evento 10, OUT2, evento 10, OUT3 e evento 10, OUT4).

Deferido o benefício da AJG e intimada a parte autora para juntar comprovantes de endereço em seu nome (evento 12, DESPADEC1), o que foi cumprido (evento 15, END2).

Deferido o pedido de urgência, no sentido de determinar que a ré oferte, em 10 dias, o tratamento à autora ou custeie o valor junto ao profissional que vem atendendo na CRON. Ainda, invertido o ônus da prova (evento 17, DESPADEC1).

A demandada manifestou-se (evento 24, PET1), informando o cumprimento da ordem liminar.

Citada, a parte ré contestou o feito (evento 27, CONT1), alegando que se trata de um contrato de plano de saúde regulamentado, uma vez que firmado após o advento da Lei 9.656/98, de 03 de junho de 1998 (Lei de Planos de Saúde - LPS), e, por isso, se sujeitando às suas regras, tampouco às normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), criada pela Lei Federal nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Sustentou que a autora teve sua solicitação indeferida, pois na bula do referido fármaco delimita suas indicações terapêuticas para outras neoplasias, não incluindo expressamente a Neurofibromatose Tipo 2. Salientou que é legítima a negativa de cobertura, eis que não se obrigou a custear tratamentos que se revelem evidentemente experimentais, especialmente aqueles considerados de uso *off-label,* os quais não possem sua devida comprovação científica e aprovação pelas agências reguladores, como a ANVISA. Ainda, sustentou a inexistência do dever de indenizar à título de danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 32, RÉPLICA1).

Intimadas as partes para dizerem acerca de outras provas que pretendam produzir (evento 35, DESPADEC1).

A demandada manifestou-se, informando que entende cabível o julgamento do processo no estado em que se encontra (evento 39, PET1).

Nada mais tendo sido requerido, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relato.

Decido.

O processo transcorreu regularmente, sem eivas ou nulidades. Não havendo preliminares pendentes de análise, passo ao exame do mérito.

Trata-se de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que requer a parte autora seja condenada a requerida ao fornecimento e custeio do tratamento com Avastin (Bevacizumabe) junto ao CRON em Lajeado/RS.

Discute-se nos autos se faz jus a parte autora ao custeio do tratamento pelo plano de saúde, eis que, conforme a ré, o medicamento não estaria incluso no rol da ANS, bem como não possui aprovação e registro junto à ANVISA, argumentando que o medicamento indicado não prescreve, em sua bula, a sua aplicação à moléstia diagnosticada, sendo considerada *off label* (fora da bula) para o medicamento, e seu uso, nesse viés, é experimental.

Inicialmente, destaca-se que o caso deve ser apreciado levando-se em conta o disposto no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

> *Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.*
>
> *§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.*
>
> *§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

A questão resta pacificada e cristalizada no enunciado sumular nº 469: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.".* Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 608, com o seguinte teor: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".*

Nestes termos, restou inadmissível que a requerida tenha se contraposto à cobertura ao tratamento prescrito à autora, indispensável para o tratamento da doença que lhe acometia. Ademais, considerando a imprescindibilidade do tratamento naquela época, deve prevalecer a cobertura contratual de modo genérico, sob pena de consideração como abusiva a cláusula ou interpretação restritiva à luz do artigo 54 do Código Consumerista.

Com efeito, incumbe ao médico assistente estabelecer o melhor tratamento a ser prescrito, de acordo com as peculiaridades da patologia de cada paciente, não sendo dado à operadora do plano de saúde negar a cobertura.

No caso em apreço, restou comprovado que o tratamento postulado se mostrava imprescindível para o tratamento da doença que acomete a consumidora, eis que a autora possui numerosos tumores que estão crescendo, colocando sua integridade neurológica em risco.

Ainda, refere-se que é essencial que a paciente inicie o imediato tratamento com o quimioterápico, eis que, as cirurgias, por sí só, não são capazes de acessar todos os tumores.

Frisa-se que, de acordo com a juntada de artigos científicos nos autos, os mesmos indicam que tal medicamento é recomendado no caso em tela, mostrando-se imprescindível nesse estágio de vida da autora.

Desta forma, em se tratando de negativa de cobertura abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, afigura-se indevida a recusa da operadora.

Ademais, depois da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de negar a cobertura ao tratamento indispensável à parte autora. Existe dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir, de forma ampla, todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessários à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, com a ressalva tão-somente das exceções previstas em Lei.

A restrição de cobertura a determinadas enfermidades ou tratamentos tem sido considerada abusiva por nossos Tribunais, por exonerar o prestador de serviços da obrigação de assumir os riscos referentes à necessidade futura de assistência médico hospitalar, dever que é inerente à finalidade do contrato.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do STJ e TJRS:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2.* ***O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.****3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021); - Grifou-se.*
>
> *CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO ADMITIDA EM TESE, MAS QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO CASO CONCRETO POR INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde*

da ANS.3. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp nº 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ.5. Conquanto admitida, em tese, a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de indicação de qual dispositivo de lei federal foi eventualmente violado, caracterizando deficiência na fundamentação e fazendo incidir à hipótese o teor da Súmula nº 284 o STF, por analogia .6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1691550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA DEVIDA. 1. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 35 DA LEI 9.656/98, POIS ENVOLVEM TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIM, INCIDE, NA ESPÉCIE, O ARTIGO 47 DO CDC, QUE DETERMINA A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 2. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO, TAMPOUCO LIMITAR O NÚMERO DE SESSÕES DAS TERAPIAS INDICADAS, POIS CABE AO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PARTE AUTORA DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA A SEGURADA. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO CONTRATO PARA A DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, NÃO IMPORTANDO A FORMA COMO O TRATAMENTO SERÁ MINISTRADO. 3. HIPÓTESE EM QUE AS PECULIARIDADES DO CASO DEMONSTRAM QUE O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA/DENVER, FONOAUDIOLOGIA COM ÊNFASE NEUROSSENSORIAL E TERAPIA OCUPACIONAL) INDICADO PELOS PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO DEVE SER DEFERIDO NOS TERMOS DISPOSTOS NA ORIGEM, SOB PENA DE OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS À SAÚDE. 4. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50248656020218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 28-04-2021);

Com relação a alegada taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde publicado pela ANS - Agência Nacional de Saúde, deve ser levado em conta que a Lei n. 9.656/98 teve alterações determinadas pela Lei n. 14.454/2022, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios <u>que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar</u>, consoante segue:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

.....” (NR)

“Art. 10. .....

.....

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

.....

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde...

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Além disso, é entendimento do STJ que os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças que receberão cobertura, **<u>mas não o tipo de tratamento</u>**, consoante se extrai do voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:

A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde. ***De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do***

consumidor. *Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02).* ***Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.*** *Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de esfíncter artificial para controle da micção.* ***O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.***

Destarte, era dever da demandada fornecer o tratamento pleiteado, sendo a procedência da demanda medida que se impõe.

Em relação aos danos morais, analisando as peculiaridades do caso, a negativa do plano de saúde configura-se como ato ilícito a ensejar reparação.

Com tal indenização, busca-se a reparação satisfativa àqueles que sofreram o abalo moral, levando-se em conta a dor e o sofrimento psicológico suportados.

Para Humberto Theodoro Júnior[1], os danos morais são aqueles:

(...) ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ("o da intimidade e da consideração pessoal"), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua

(...) quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida

No mesmo sentido, Carlos Alberto Bittar[2] destaca que os danos morais:

(...) se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado

Assim, no que pertine à indenização por danos morais, não há dúvidas da sua aplicabilidade ao caso dos autos em face da ofensa comprovadamente perpetrada à integridade física da paciente.

No entanto, na fixação do *quantum*, não se pode permitir o enriquecimento indevido, com a fixação de montantes excessivos, assim como não pode haver valor ínfimo que sequer compense o dano experimentado pela vítima, pois o ressarcimento deve servir para evitar a repetição da conduta danosa.

Portanto, deve-se analisar o caso concreto, considerando as condições econômicas das partes, a repercussão do dano e o grau de culpa quando do evento danoso, sem deixar de lado os parâmetros adotados pela doutrina e jurisprudência para que o dano seja devidamente ressarcido, razão pela qual o fixo no montante de R$ 5.000,00, a ser acrescido da Taxa SELIC, desde a citação da demandada.

Nesse sentido é o entendimento do STJ e do TJRS em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO.
USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 2. ***É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental. 3. Havendo a indevida recusa ao fornecimento de tratamento pela operadora de saúde e reconhecendo a corte de origem ser inegável a dor e o sofrimento experimentados pelo beneficiário de plano, é cabível a condenação a indenização por danos morais.*** *4. Agravo interno desprovido. (AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0360346-9, T4 - QUARTA TURMA, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Julgado em: 08/04/2024) - Grifou-se*

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, e para fins do art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **ALICIA MOTA DE ALMEIDA** em face de **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.** para:

a) tornar definitiva a tutela liminar de urgência (evento 17, DESPADEC1), determinando à demandada que forneça o imediato tratamento do medicamento AVASTIN (Bevacizumabe), a ser executado no CRON - Centro Regional de Oncologia de Lajeado-RS, por prazo indeterminado, conforme orientação médica;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido da Taxa SELIC, a contar da citação da demandada.

Face a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do procurador da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, proceda-se a baixa.

Documento assinado eletronicamente por **CARMEN LUIZA ROSA CONSTANTE, Juíza de Direito**, em 07/02/2025, às 13:16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10076325683v40** e o código CRC **64944ddc**.

1. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, pp. 2 e 8. ↩

2. BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1993, p. 31 ↩